

Spektrum AUD

Problem alkoholowy to skala, nie dychotomia. Im wcześniej rozpoznasz, gdzie jesteś — tym skuteczniej możesz wpłynąć na to, co dalej.

CZAS: 15 min 11 kryteriów DSM-5 **ŹRÓDŁO:** DSM-5 (APA, 2013); ICD-11 (WHO, 2019); Grant i wsp. (2015)

JAK UŻYWAĆ

Przeczytaj **11 kryteriów** diagnostycznych AUD (ang. *Alcohol Use Disorder, zaburzenie używania alkoholu*) według DSM-5. Zaznacz te, które dotyczą Cię w ciągu **ostatnich 12 miesięcy**. Policz zaznaczenia: **2-3** = AUD łagodne, **4-5** = umiarkowane, **≥6** = ciężkie. Następnie zapisz swoją refleksję w polu na dole.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Tradycyjny model „alkoholik / nie-alkoholik” jest fałszywy klinicznie. AUD to **spektrum** — jak ciśnienie krwi. W badaniu *NESARC-III* (Grant 2015, N=36 309) ~14% dorosłych spełniało kryteria AUD, z czego większość — **łagodne**. Język spektrum redukuje stygmatyzację i zwiększa gotowość do zmiany. Wczesna interwencja w łagodnym AUD jest najskuteczniejsza (d=0.30-0.50; *NIAAA*).

01 11 kryteriów DSM-5 — zaznacz, co dotyczy Cię w ciągu 12 miesięcy

1 **Ilość/czas** — piję więcej lub dłużej, niż zamierzałem/-am. ☐

2 **Próby ograniczenia** — chciałem/-am ograniczyć picie, ale nie udało się. ☐

3 **Czas** — dużo czasu poświęcam na zdobywanie, picie lub dochodzenie do siebie. ☐

4 **Głód alkoholowy** (ang. *craving*) — silne pragnienie wypicia. ☐

5 **Obowiązki** — picie utrudnia mi pracę, naukę lub obowiązki domowe. ☐

6 **Relacje** — piję pomimo problemów z bliskimi, których to dotyczy. ☐

7 **Wycofanie** — porzucam ważne aktywności (hobby, sport, spotkania) na rzecz picia. ☐

8 **Ryzyko** — piję w sytuacjach niebezpiecznych (prowadzenie, praca). ☐

9 **Zdrowie** — piję pomimo problemów zdrowotnych (wątroba, nadciśnienie, sen). ☐

10 **Tolerancja** — muszę pić więcej, żeby osiągnąć ten sam efekt. ☐

11 **Odstawienie** — drżenie, poty, niepokój, gdy nie piję; piję, by je złagodzić. ☐

Kryteria 10 i 11 (pomarańczowe) wskazują na **zależność fizyczną** — wymagają konsultacji medycznej przed odstawieniem (ryzyko drgawek).

02 Twój wynik — ciężkość AUD

2-3 PUNKTY

AUD łagodne

Wczesna interwencja najskuteczniejsza. Krótka interwencja, dziennik picia, redukcja.

4-5 PUNKTÓW

AUD umiarkowane

Leczenie ambulatoryjne, MI (ang. *motivational interviewing*), ewentualnie farmakoterapia.

≥6 PUNKTÓW

AUD ciężkie

Leczenie specjalistyczne, abstynencja, farmakoterapia. Przy zależności fizycznej — kontrolowany detoks.

03 Język spektrum — dlaczego to nie jest tylko semantyka

Etykieta „alkoholik” pochodzi z innej epoki — z czasów, gdy uzależnienie rozumiano jako wadę charakteru. Dziś wiemy, że problem alkoholowy to **stopniowalny zespół objawów** związanych z neurobiologią mózgu, genetyką (~50% wariancji) i czynnikami środowiskowymi. Język spektrum ma trzy konkretne konsekwencje kliniczne.

REDUKCJA STYGMATYZACJI

„Mam łagodne AUD” jest *łatwiej zaakceptować* niż „jestem alkoholikiem”. Pacjenci, którzy słyszą diagnozę spektrum, chętniej wracają na kolejne wizyty.

WCZESNA INTERWENCJA

W łagodnym AUD *krótka interwencja* 5–15 min ma siłę efektu $d=0.30$. W ciężkim AUD potrzebne jest leczenie kompleksowe. Im wcześniej — tym mniej trzeba.

ELASTYCZNOŚĆ CELÓW

Łagodne/umiarkowane AUD daje przestrzeń na *redukcję* jako pierwszy cel. Ciężkie AUD zwykle wymaga abstynencji. Diagnoza spektrum dopasowuje cel do realnych możliwości mózgu.

04 Moja refleksja

MÓJ WYNIK

— ile kryteriów zaznaczyłem/-am

CO MNIE NAJBARDZIEJ ZASKOCZYŁO

KTÓRE KRYTERIUM BYŁO DLA MNIE NAJTRUDNIEJSZE DO ZAZNACZENIA

— i dlaczego

PIERWSZY MAŁY KROK, KTÓRY CHCĘ ZROBIĆ W TYM TYGODNIU

Klucz: AUD to spektrum — jak ciśnienie krwi czy poziom cholesterolu. Nie musisz być „pełnoobjawowym alkoholikiem”, żeby skorzystać z pomocy. *Wczesna interwencja w łagodnym AUD ma najwyższą skuteczność* (Kaner i wsp., 2018; meta-analiza Cochrane, 34 RCT, $d=0.30$). Każde zaznaczone kryterium to informacja, nie wyrok.